



SANNA EN RED: FUNDAMENTACIÓN

DR. JUAN ALBERTO REICHENBACH

Un manual que nos oriente en los problemas reales. Con niños y niñas nominados/as. En su contexto. Con reflexiones necesarias para aprender y enseñar. Autoevaluaciones reflexivas. Bibliografía accesible y socializada. Stock de educación virtual. Libros originales de nuestra red. Con miles de estudiantes.

Con nuestra identidad editorial, y analizando nuestros perfiles epidemiológicos. Con autores/as de distintas escuelas de medicina que han integrado la innovación curricular como eje. Del país entero y de Latinoamérica. Con la participación de todos los sectores del claustro académico, sobre todo con alumnos/as. Y fundamentalmente, con la comunidad.

Con una visión integral, con centro en la concepción del niño y la niña como sujetos de derecho y con una perspectiva de género.

Iniciamos un camino en el grado que hemos recorrido en el Post grado. Que no es más que un continuum sin fin. Y este es el producto. Polisémico. Variado. Reflexivo.

Una estimulante aventura, como todos los inicios.

El Propósito de “La RED SaNNA” es acompañar y orientar a los/as estudiantes en el proceso de aprendizaje sobre situaciones y problemas de salud y enfermedad de niños, niñas y adolescentes. Los conocimientos, habilidades y competencias para su adecuada atención plantean un desafío motivacional adicional, teniendo en cuenta que, en el futuro de su práctica profesional y laboral, contribuirán al desarrollo de la salud infantojuvenil y de toda la potencialidad que de ella deriva, en el escenario social y de ciudadanía.

Veinte problemas de salud explican casi el 90% del total de las consultas programadas y espontáneas. Éstos requieren mínima complejidad de equipamiento tecnológico para su atención, 5 o 6 fármacos de la “vieja generación”, muy pocos estudios complementarios oportunos de laboratorio y una adecuada y sistemática nominalización para la prevención y promoción de la salud; y actitud humanitaria, escucha empática, habilidades de comunicación para comprender y facilitar la comprensión a pacientes y familias. También requieren de la clínica pediátrica en su acepción integral, con una educación basada en casos y problemas, las evidencias y la participación en la toma de decisiones del equipo de salud, del/la paciente y la familia.

El programa de la asignatura SaNNA (Salud del Niño, Niña y Adolescente) atiende las prioridades sociales de salud y tiene en cuenta los principales problemas maternoinfantiles y de la adolescencia, insertos en su familia, su ambiente, su cultura y su condición socioeconómica, jerarquizando el enfoque de salud por sobre el de enfermedad, la intervención de promoción y prevención por sobre la de curación y reparación tardía, a través de la construcción dinámica de esquemas reflexivos que generen en el estudiante el interés y la necesidad de la educación continua. Y prioriza la extensión y la investigación. Esos dos ausentes.

Y la educación permanente a través del Portal: “El Portal de Salud del Niño”, Niña y Adolescente, desde la escuela de Gobierno en Salud “Florencia Ferrer” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del cual soy director Editorial. Y la red nacional de todo el equipo de salud.

Se priorizan aquellas temáticas y problemáticas prevalentes en la comunidad que generan demandas de atención y cuidados de niños, niñas y adolescentes en el primer nivel y que requieren los conocimientos necesarios para una correcta aproximación diagnóstica y resolución en forma ambulatoria como también la detección oportuna de situaciones de riesgo que precisan una derivación a niveles de mayor complejidad de atención y/o especialidades médico-pediátricas. Complementariamente, aquellos conocimientos para el manejo inicial de pacientes graves antes

MAPA CONCEPTUAL DE SANNA EN RED

Los ejes de la Innovación en la educación médica	El sustrato de análisis	Sus formas
La clínica	Los perfiles epidemiológicos interactivos	La educación centrada en el estudiante
La historia clínica	Las prioridades sociales	La educación continua
La relación médico paciente	La bioética	La investigación acción
El análisis de problemas	La medicina basada en la comunidad y el estudiante	El arte de adaptación dinámica a cada situación

de su derivación o internación.

La educación en el grado y el posgrado es estructural para el capital humano necesario que requieran las políticas públicas. Son las competencias para el aquí, el ahora, y para la transformación de la cultura de la enfermedad en la cultura de la salud.

El manual permitirá a los/as lectores/as:

1. Abordar las problemáticas de salud infantojuvenil desde la perspectiva de prevalencia de la morbimortalidad regional y nacional
2. Conocer y analizar las estadísticas vitales de morbimortalidad infantil de nuestro país
3. Abordar las problemáticas de la atención de la salud desde la perspectiva de la semiología, de variantes de la normalidad, de los signos y síntomas de alarma y derivación oportuna
4. Conceptualizar la Historia Clínica Familiar como la herramienta fundamental, con énfasis en la semiología de la anamnesis y el examen físico
5. Desarrollar habilidades clínicas y de relación con los niños, niñas, adolescentes y adultos/as cuidadores/as considerando la edad y las características individuales y particulares de cada familia
6. Desarrollar habilidades de comunicación para brindar información adecuada y oportuna sobre la situación de salud del niño, niña y adolescente
7. Integrar conceptos de la semiología y la fisiopatología que orientan el diagnóstico presuntivo y los diagnósticos diferenciales en salud y enfermedad
8. Identificar y reconocer las patologías perinatales más frecuentes de RN, signos de alarma, manifestaciones clínicas y diagnósticos diferenciales
9. Analizar factores de riesgo materno y su incidencia en la patología perinatalIdentificar las causas más frecuentes de consulta ambulatoria y los criterios de alarma
10. Aprender la terapéutica apropiada para las patologías más frecuentes de resolución ambulatoria
11. Aprender la terapéutica apropiada para el manejo inicial de las patologías más frecuentes que requieren internación
12. Aprender a reflexionar sobre la complejidad de los problemas de salud en la infancia y abordar los problemas prevalentes con intervenciones racionales y posibles, considerando siempre

la participación del equipo de salud

13. Considerar los Derechos del/la niño/a y el marco ético y legal en todas las intervenciones que se requieran desde el equipo de salud

El esquema pedagógico permitirá abordar cientos de situaciones de la práctica real en los escenarios habituales, priorizando la promoción, la prevención, la anticipación, el diagnóstico y la derivación oportuna, con la clínica de niños/as y de las comunidades, con el derecho a la salud integral y la perspectiva de género.

El detalle de los contenidos se presentan en el índice de la obra, y se incluyen como anexo en el Portal SaNNA, organizador central de la formación continua.

El aprendizaje por competencias estructura la actividad y las habilidades a adquirir, y será seguramente la guía del tomo 2 de esta obra que hoy presentamos.

Los libros “Pediatría en red 1, 2 y 3”, imaginados para el posgrado, han apoyado este emprendimiento editorial de grado.

Claro que esa línea divisoria es ficcional. La educación es un tren sin fronteras. Con estaciones graduales, complementarias, que deben ser revisadas. Que queremos revisar. Que deben ser programadas cronológicamente, consensuadamente, adhesiva y complementariamente entre los responsables de los ministerios, las facultades nacionales, las sociedades científicas y los colegios profesionales.

Contamos con material docente de fuentes y formatos diversos que se pone a disposición de estudiantes y lectores/as.

El Abordaje Integral del Proceso Salud Enfermedad Atención nos hace repensar nuestro rol de pediatras. “La enfermedad es un proceso que no resulta de la acción externa de un agente ambiental agresivo, ni de la reacción internalizada de un huésped susceptible, sino de un proceso totalizador de efectos patológicos”, según Almeida Filho.

Rojas afirma que “la salud es un continuo en permanente tensión y conflicto en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Este proceso está condicionado por las potencialidades, capacidades y limitaciones que las personas, las familias y las comunidades evidencian en el manejo de los recursos disponibles”.

Souza Campos expresa que “hay que reconocer como sujeto de cuidado a la persona en su contexto socio-familiar, desplazando y ampliando la mirada desde el órgano enfermo a la persona en su contexto. De esta forma si la enfermedad se coloca entre paréntesis, la mirada deja de ser exclusivamente técnica, clínica y aparece en escena la persona como sujeto concreto, social y subjetivamente constituido”.

Quizás por aquello de Dostoievski “el llanto de un solo niño no justifica orden cósmico alguno” o porque (Donald Winnicott): “Un bebé no puede existir solo, sino que constituye una parte esencial de una relación”.

Con el criterio de la interdisciplina siguiendo a la psicoanalista María Cristina Rojas “la interdisciplina es más que el reparto del ser humano entre distintos especialistas; por el contrario, aspira a la consideración integral de un sujeto en redes, e implica también el atravesamiento del grupo de trabajo por líneas específicas de cada disciplina. En nuestra era de la hiper especialización se enfatiza el desarrollo de estas tramas que implican, además, la exigencia de mantener la especificidad del texto disciplinario en el intertexto-interdisciplinario”. Claro que este es solo un vehículo para aportar en el proceso de enseñanza aprendizaje al capital humano en este presente. “Yo no hablo del principio y del fin. Jamás hubo otro principio que el de ahora, ni más juventud o vejez que las de ahora, Y nunca habrá otra perfección que la de ahora, ni más cielo o infierno que éstos de ahora”, afirmaba Walth Whitman.

Educación en problemas complejos, aprender de la comunidad, generar aptitudes y actitudes pues Aristóteles advertía que “Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”.

Y es por esto que la bioética, los derechos, la humanización y el arte ocupan renglones en un libro de una medicina que no quiere ser hegemónica. Que quiere descubrir el secreto de la salud de los unos, de los otros y de todos, con y para todos.

Competencias para la realidad, para el contexto, para este presente sanitario infantil.

“Realizar un Abordaje Integral del Proceso Salud Enfermedad Atención (según Jure y Ciuffolini) requiere asumir el desafío de reflexionar sobre nuestros espacios de práctica y comprender que nuestras formas de pensar y organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, presupone cierta manera de conceptualizar el problema de salud-enfermedad, en cierto tiempo y en cierto contexto familiar y comunitario. Los modos de construcción y reconstrucción de los aprendizajes se encuentran indefectiblemente vinculados a ciertos intereses que sustentan las prácticas de los equipos interdisciplinarios de salud y que permiten el análisis y reflexión crítica sobre el proceso enseñanza -aprendizaje en las facultades de ciencias de la salud y en los postgrados, y en los lugares de ejecución de las políticas públicas”.

Entonces los problemas se complejizan y analizamos una cultura, un tiempo, un ambiente, la equidad, las creencias, que generan esa tensión de la salud y la enfermedad.

Y los problemas exceden los tejidos, las neuronas y los órganos aislados. Y se reconocen en las evidencias cotidianas.

El propósito deviene claramente del fondo y la forma de “La RED SaNNA”. Fue desde mi perfil académico predominante que accedí al cargo de Director Nacional de Maternidad e Infancia de nuestro país, he trabajado 43 años en relación a los Hospitales más complejos de la enfermedad infantil, y también en los territorios, los más alejados y anónimos de nuestra geografía. Soy docente casi del origen. La docencia y la salud pública son indivisibles si están aplicadas al bienestar de nuestro futuro. Por ello, quizá lo más trascendente es esta empresa de formar el capital humano pensando en la realidad sanitaria del contexto. Esa que nos advierte que:

Es necesario imaginar la salud del niño, la niña, l@s adolescentes y las madres desde la integralidad, el derecho y con una perspectiva de género, orientando las políticas públicas a esos propósitos.

Incluir en este concepto ampliado de salud la influencia negativa que los cambios demográficos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, educativos, alimentarios y la violencia le imprimen. De ello deviene la necesidad de jerarquizar las prioridades sociales de la mujer, la madre, la embarazada, el/la recién nacido/a, el niño, la niña y los adolescentes.

Habrà que actuar sobre la multiplicidad de factores que condicionan morbilidad y sobre la mortalidad reducible.

Serà necesario recordar que la Argentina cursa una etapa de transición demográfica, con disminución de la natalidad, y que la niñez-infancia-adolescencia es UN TERCIO DE LA POBLACIÓN y es el futuro.

Habrà que reconocer que es insatisfactoria la disminución de la tasa de mortalidad infantil y que además persiste una gran inequidad interjurisdiccional, entre localidades de una misma provincia y entre barrios de una misma localidad.

Es evidente que hay aún muchas/as recién nacidos/as con bajo peso al nacer, muchos/as prematuros/as y maternidad adolescente con riesgos. Las muertes perinatales y en el primer año de vida son REDUCIBLES con MEDIDAS SIMPLES, basadas en la APS, la territorialización, la promoción, la integralidad, la inclusión y el rescate de derechos.

Es claro y preocupante que la violencia atraviesa todas las edades desde el año de vida, que la mitad de las muertes antes del año de vida son reducibles por acciones en el período perinatal, que el aborto es de las principales causas de muerte en madres embarazadas.

Que las enfermedades infecciosas, emergentes, reemergentes y olvidada siguen siendo una causa importante de morbilidad en la Argentina (lúes, TBC, coqueluche, dengue, sarampión, Hantavirus, Chagas, VIH, y ahora la pandemia mundial Covid 19).

Que se han abandonado en los últimos años las políticas públicas de educación sexual, prevención de ETS, embarazos adolescentes, abortos inseguros, falta de detección precoz del embarazo, de control del mismo, de atención adecuada en sala de partos, de seguimiento en maternidades con Condiciones obstétricas neonatales esenciales (CONE), de seguimiento del puerperio y del RN de riesgo.

Que hay un alarmante incumplimiento del calendario nacional de vacunaciones y meseta en el objetivo supremo de la universalización de la lactancia materna.

Que continúa incidiendo el síndrome urémico hemolítico.

Que hay que mejorar la detección y derivación de recién nacidos/as o por nacer con cardiopatías congénitas.

Que continuamos en emergencia alimentaria, que hay que erradicar el hambre y las enfermedades de la malnutrición, incluida la anemia y la carencia de oligoelementos.

Que se debe mejorar el abandono interanual en el ciclo primario y secundario y eliminar el trabajo infantil y adolescente, con la perspectiva urgente de género.

Que se debe incluir en la agenda pública la salud mental, la “epidemia” de suicidios adolescentes y los accidentes en la vía pública.

Que habrá que sanear el agua, el aire, los suelos, el medio ambiente reparando en esta invasión creciente de agroquímicos y tóxicos industriales.

Que habrá que pensar desde las políticas públicas en una salud para el niño, la niña y los adolescentes centrada en derechos y con perspectiva de género.

Que la pandemia Covid ha generado miseria, hambre, desocupación, pérdida de vidas, de capital humano en salud y desatención de los niveles iniciales de atención.

Ojalá “La RED SaNNA” sane.

Y sea una herramienta útil para la mutación de la tristeza en sonrisas.

